

ITEM 199 : DYSPNÉE AIGÜE ET CHRONIQUE

Dyspnée = perception anormale et désagréable de la respiration → gêne respiratoire subjective ± angoissante

- La respiration dépend de :
 - La **stimulation des mécanorécepteurs thoraciques** : paroi thoracique, muscles respiratoires, bronches et poumons
 - Du **contenu artériel en oxygène** : fonction du taux d'Hb, de la SaO₂ et du débit cardiaque
 - Du **pH sanguin** : récepteurs dans le SNC
- La dyspnée résulte d'une inadéquation de la commande et de l'efficacité du système respiratoire

Caractérisation	Dysrythmies respiratoires	- Dyspnée de Küssmaul (souvent acidose métabolique) = en 4 temps : inspiration profonde – pause – expiration profonde – pause - Dyspnée de Cheyne-Stokes (affection neurologique sévère, IC grave) : dyspnée anarchique avec mouvements respiratoires de plus en plus amples et rapides, souvent suivis d'une pause prolongée	
	Circonstances de survenue	Chronologie	- Dyspnée aiguë : installation brutale en quelques heures/jours - Dyspnée chronique : installation progressive sur plusieurs semaines/mois
		Cycle respiratoire	- Dyspnée inspiratoire (↗ du temps inspiratoire) : pathologie des voies aériennes supérieures (pharyngée, laryngée ou trachéale) - Dyspnée expiratoire (↗ du temps expiratoire) : pathologie bronchique ± sifflements intra-thoraciques
		Position	- Orthopnée : ↗ par la position couchée → insuffisance cardiaque, dysfonction diaphragmatique, obésité - Antépnée : ↗ penchée en avant → dysfonction diaphragmatique, obésité - Platypnée : ↗ par l'orthostatisme → syndrome hépato-pulmonaire, shunt intra-pulmonaire, malformation artério-veineuse
		Horaires	- Nocturne : asthme (fin de nuit), insuffisance cardiaque (orthopnée)
		Facteur déclenchant	- Dyspnée de repos ou d'effort - Facteurs déclenchant : allergène (asthme), écart de régime désodé (insuffisance cardiaque), tabac, exposition professionnelle, prise médicamenteuse...
	Signes associés	- Selon la FR : bradypnée (< 15/min) ou tachypnée (> 25/min) - Selon la ventilation-minute (VC x FR) : polypnée (↗) ou hypopnée (↘) - Symptômes associés : douleur thoracique, toux, expectorations, wheezing, cornage - Auscultation pulmonaire : abolition du MV, bruits surajoutés (sibilant, bronchi, crépitant) - Signes respiratoires : ↗ ou ↘ des vibrations vocales, mise en jeu des muscles inspiratoires du cou, respiration abdominale paradoxale - Signes d'insuffisance cardiaque droite et/ou gauche - Signes extra-respiratoires : fièvre, signes cutanés, articulaires, digestifs, neurologiques...	
	Quantification : échelles de dyspnée	EVA	= De aucun d'essoufflement (0) à essoufflement maximal (10)
		Echelle de Borg	= Selon la sensation : nulle (0), légère (2), modérée (3), forte (5), très forte (7), maximale (10)
		Echelle fonctionnelle de la NYHA	= Retentissement fonctionnel sur l'activité physique : classes 1 (aucune limitation), 2 (limitation légère à modérée), 3 (limitation marquée) et 4 (au moindre effort/au repos)
		Echelle du Medical Research Council (MRC)	= Retentissement sur les activités de la vie quotidienne - Stade 0 : pour des efforts soutenus (montée de ≥ 2 étages) - Stade 1 : lors de la marche rapide à plat ou en pente légère - Stade 2 : marche sur terrain plat en suivant quelqu'un du même âge - Stade 3 : obligeant à s'arrêter pour reprendre son souffle après quelques minutes ou 100 mètres sur terrain plat - Stade 4 : dyspnée au moindre effort
		Echelle de Sadoul	- Stade I : dyspnée pour des efforts importants - Stade II : dyspnée à la marche rapide ou en pente légère - Stade III : dyspnée à la marche à plat à allure normale - Stade IV : dyspnée à la marche lente - Stade V : dyspnée au moindre effort

DYSPNEE AIGUË

- Urgence : - Apprécier la gravité et pratiquer les gestes en urgence selon l'état clinique
 - Diagnostic étiologique et traitement → selon la présence d'une anomalie auscultatoire ou non
- 3 examens indispensables : **RP de face, ECG, GDS**
- Autres selon le contexte : **TDM, échocardiographie, D-dimères, NT-pro-BNP, fibroscopie bronchique...**

Gravité	- Détresse respiratoire aiguë : cyanose, sueurs (choc, hypercapnie), polypnée/bradypnée, tirage, mise en jeu des muscles respiratoires accessoires (intercostaux, SCM, battement des ailes du nez), respiration abdominale paradoxale - Retentissement hémodynamique : tachycardie > 110 bpm, signes de choc (marbrures, oligurie, extrémités froides), collapsus (PAS < 90 mmHg), signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë (turgescence jugulaire, OMI, signe de Harzer) - Retentissement neurologique : angoisse, agitation, torpeur, astéraxis, voire coma		
	- Interruption de régime hyposodé ou de traitement : OAP, asthme - Notion de voyage aérien ou chirurgie récente : EP - Inhalation d'un corps étranger - Exposition allergénique : œdème de Quincke, asthme - Syndrome infectieux : pneumopathie, pleurésie, laryngite - Douleur thoracique : pneumothorax, pleurésie, pneumopathie, OAP		
Étiologie	Anomalie de l'auscultation	Dyspnée aiguë inspiratoire ou mixte	→ Obstacle laryngé ou trachéal haut à la pénétration de l'air : bradypnée ± cornage ± dysphonie si atteinte des cordes vocales - Obstacle tumoral (chez l'adulte) : tumeur pharyngée, laryngée, trachéale, goitre - Infection (surtout enfant) : épiglottite aiguë, laryngite aiguë virale - Réaction allergique (allergie alimentaire, prise médicamenteuse, Œdème de Quincke) : œdème glottique suraigu ± choc anaphylactique - Inhalation de corps étranger : syndrome de pénétration - Dysfonction aiguë des cordes vocales (rarement) : crises de dyspnée aiguë, récidivantes, diurne, à début et fin brutal (≈ crise d'asthme) → fermeture paradoxale des cordes vocales à l'inspiration
		Dyspnée aiguë avec râles sibilants	- Asthme aigu ou bronchiolite chez l'enfant - Exacerbation aiguë de BPCO : tabagisme, toux chronique, infection bactérienne/virale - Pseudo-asthme cardiaque (insuffisance cardiaque gauche) : patient âgé, crépitations souvent associés, contexte (HTA, cardiopathie ischémique ou valvulaire)
		Dyspnée aiguë avec râles crépitants	- Insuffisance cardiaque gauche : FdRCV, cardiopathie ischémique, tableau d'OAP - Pneumopathie infectieuse : syndrome infectieux, terrain favorisant (âge, alcoolisme, ID), râles crépitants en foyer, souffle tubaire en regard de la condensation pulmonaire - SDRA : œdème pulmonaire lésionnel (gaz toxique, infection respiratoire ou extra-respiratoire, traumatisme, pancréatite, inhalation, brûlure...) - Pneumopathie d'hypersensibilité : poumon de fermier, maladie des éleveurs d'oiseaux - Pneumopathie médicamenteuse aiguë : rechercher introduction récente d'un médicament - Hémorragie intra-alvéolaire : vascularite
		Dyspnée aiguë avec asymétrie auscultatoire	→ Abolition du murmure vésiculaire du côté atteint - Pneumothorax - Epanchement pleural liquidien (pleurésie) : contexte infectieux, tumoral ou trauma - Atélectasie aiguë : le plus souvent chez l'enfant par inhalation de CE
	Auscultation normale	Origine cardio-vasculaire	- Embolie pulmonaire : rechercher des FdR, examen clinique et RP souvent normaux - Trouble du rythme cardiaque aigu : FA, flutter, tachysystolie, TV - Epanchement péricardique abondant de constitution récente (tamponnade)
		Anémie aiguë	= Hémorragie aiguë ou hémolyse aiguë (bactérienne, paludisme, toxique, immuno-allergique, auto-immune ou mécanique)
		Acidose métabolique	= Acidocétose diabétique, acidose lactique, insuffisance rénale aiguë, perte de bicarbonates digestive (diarrhée aiguë importante)
		Origine neurologique	- AVC (dyspnée de Cheynes-Stokes) - Neuropathie périphérique (notamment syndrome de Guillain-Barré) - Crise aiguë myasthénique
		Dyspnée psychogène	→ Diagnostic d'élimination

DYSPNEE CHRONIQUE

- Bilan minimal devant une dyspnée chronique isolée : - **Dosage de l'Hb**

- **RP**

- **EFR**

- **ECG**

± **Echocardiographie**

Etiologie	Maladie pulmonaire chronique	TVO	- BPCO : fumeur/ancien fumeur, dyspnée progressive ± associé à une bronchite chronique (toux, expectoration), TVO non réversible, emphysème au TDM - Asthme : terrain atopique, non fumeur, TVO réversible
		TVR	Atteinte de la pompe ventilatoire ou de la commande centrale : - Hypoventilation pariétale : cyphoscoliose, grande obésité - Pathologie neuromusculaire : lésion spinale, myopathie, SLA, centrale Pneumopathie interstitielle diffuse
	Maladie cardiaque chronique		- Insuffisance cardiaque (toute cause) : ischémique, hypertensive, myocardiopathie restrictive, valvulopathie, péricardite constrictive...
	Hypertension pulmonaire		- Signe d'appel peu spécifique : - Dyspnée d'effort progressive inexpliquée - Douleur thoracique - Syncope d'effort - Examen physique : éclat du B2 au foyer pulmonaire, souffle d'insuffisance tricuspidale, signes d'insuffisance cardiaque droite - Dépistage : échocardiographie - Diagnostic de certitude : cathétérisme cardiaque droit
	Anomalie de transport de l'oxygène		- Anémie chronique : saignement occulte, hémolyse chronique... - Intoxication à l'oxyde de carbone (CO) - Méthémoglobinémie : intoxication aux nitrates/nitrites, engrais azoté, congénitale - Sulfhémoglobinémie acquise (toxique)
	Dyspnée chronique psychogène		→ Diagnostic d'élimination - Souvent jeune femme, se plaignant d'une dyspnée majeure - Contexte psychologique : anxiété avec attaque panique - Pauses et soupirs répétés, alcalose respiratoire - TTT : rééducation respiratoire par kiné spécialisé